

Случай первично-множественного (метахронного) рака желудка и пищевода

Дюсембеков С.Т., Койшыбаев А.К., Бегунов В.В., Реджабаева Л.Ш.

Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. М. Оспанова

Первично-множественные злокачественные опухоли (ПМЗО), или полинеоплазии, – одновременное (синхронное) или поочередное (метахронное) заболевание. Все они развиваются самостоятельно и независимо друг от друга в одном или нескольких органах человека. У лиц ранее перенесших злокачественное заболевание риск возникновения второй опухоли в 1,3 раза выше, чем у лиц ранее не болевших (1,2). В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению вторичных опухолей, что по всей видимости связано с появлением более эффективных методов диагностики и лечения, которая позволяет дожить пациенту до возникновения второй и третьей опухоли. Частота ПМЗО в среднем встречается у 13-15% больных злокачественными опухолями (3). Работа над этой проблемой позволяет установить пациентов с повышенным риском появления второй злокачественной опухоли. Поэтому правильно поставленный диагноз позволяет провести специальное лечение, что в последующем улучшает качество жизни больного и продлевает его жизнь.

По данным (4) первично-множественные опухоли выявлены у 15 из 481 оперированных больных. Наиболее частыми локализациями были молочная железа 6 случаев и рак толстой кишки 3. По результатам (5,6) множественные опухоли пищевода составляют 6,8% от общего числа раком пищевода. Сочетание рака пищевода с опухолью желудка составляет 12-18% метахронных и 30% синхронных. Частота выявления метахронного рака желудка и пищевода составляет приблизительно 27,3%.

Исторически, в исследовании ПМЗО можно выделить три этапа: первый связан с открытием в 1793 году Дж.Пирсоном случая первично множественных злокачественных опухолей; второй, когда 1889 г. Бильрот предложил клинко-морфологические критерии первичных множественных злокачественных новообразований; третий период – с 70-х гг. XX столетия, когда появились когортные эпидемиологические исследования этой патологии с научным определением зависимости между первым и риском развития второго и последующих злокачественных заболеваний у больного.

Приводим пример: больной Х, 38 лет поступил в отделение общей хирургии ЦКМ ЗКГМА им.М.Оспанова в экстренном порядке 12.01.06 года с клиническим диагнозом: Острый панкреатит. Жалобы при поступлении на боли в эпигастрии, тошноту, рвоту, слабость. Из анамнеза заболел остро, когда стали беспокоить вышеперечисленные жалобы. В связи с ухудшением общего состояния доставлен «каретой» скорой помощи в отделение экстренной хирургии. При проведении диагностических мероприятий у больного выявлены следующие данные ФГДС от 13.01.06 г картина характерна для язвенной болезни пилороантрального отдела желудка с явлениями стеноза данной зоны. При контрастировании желудка у больного выявлен декомпенсированный стеноз выходного отдела. Со стороны лабораторных анализов патологических изменений не выявлено. При цитологическом и гистологическом исследовании биопсийного материала данных за малигнизацию не обнаружено. 18.01.06 года больному под

общей анестезией произведена лапаротомия, при ревизии обнаружена инфильтративная карцинома дистальной части желудка. Больному произведена гастропленэктомия с лимфодиссекцией в объеме Д2. Послеоперационный период протекал гладко. Гистограмма опухоли № 1266-79 недифференцированная аденокарцинома желудка с проращением до серозной оболочки. Метастазов в лимфоузлах не обнаружено. На 14 сутки выписан под наблюдение участкового врача и районколога.

В марте 2007 года вновь обратился к врачу по поводу дисфагии. При рентгенологическом исследовании в проекции среднегрудного отдела пищевода обнаружена инфильтративная карцинома протяженностью до 3 см. Эндоскопически на расстоянии 30 см имеется циркулярное сужение просвета пищевода. Гистограмма опухоли № 9438-64 низкодифференцированный плоскоклеточный рак пищевода. После предоперационной подготовки больному произведена операция субтотальной резекции пищевода с резекцией анастомозированных отделов тонкой кишки и пластика поперечным отделом толстой кишки с наложением концебокового, инвагинационного пищеводотолстокишечного анастомоза в правой плевральной полости, толстотонкокишечного и толстотолстокишечного анастомозов. Послеоперационный период протекал гладко.

Энтеральное питание начато на 5 сутки. Выписан из отделения на 14 сутки. Гистологическое заключение операционного материала: 6363-65 низкодифференцированный рак пищевода с проращением до мышечной оболочки. Метастазов в лимфоузлах не выявлено.

Таким образом, наличие в анамнезе злокачественной опухоли говорит о возможности возникновения второй опухоли в организме больного. В данном случае у больного в течении года возникло метахронное злокачественное заболевание желудка и пищевода. Хирургическое лечение не отличается от лечения солитарных опухолей тех же локализации и остаётся ведущим среди специальных методов лечения. Данный случай мы считаем интересным для клиницистов редкостью патологии и необычностью выбранной тактики лечения.

Список литературы

1. Newell G, Kremenitz E, Robertz J. Multiple primary neoplasms in blacks compared to whites. Further cancer in patients with cancer of the digestive organs. J Natl Cancer Inst 1975; 54: 331-4.
2. Schoenberg B. Multiple primary malignant neoplasms. The Connecticut experience. 1935-1964/ Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag.; 1977; 173.
3. Трапезников Н.Н., Поддубной И.В. Справочник по онкологии. Под ред. Акад. РАМН Н.Н. Трапезникова и проф. И.В. Поддубной. 1996; стр. 150-2.
4. Черноусов А.Ф., Поликарпов С.А., Черноусов Ф.А. Хирургия рака желудка. ИздАТ, 2004, с.102-104.
5. Пирогов А.И., Рындин В.Д., Джуманазаров М.С. Множественность злокачественных опухолей пищевода // Здравоохран. Казахстана. - 1981. - №1. - С.34-38.
6. Самсонов В.А. и др. Первично-множественные злокачественные опухоли при раке пищевода // Вопр.онкол., 1989. - Т. XXV. - №3. - С.362-364.